EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88696
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-17 09:22:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA HERMINDA GARRIDO VENEGAS			RUN	: 6.815.539-8
F.Nac	: 13-02-1948	Edad	: 76 AÑOS, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: EL MANZANO			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 985866323		
Fecha Ingreso	: 2024-07-15	Fecha Egreso	: 2024-07-17 09:22:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Exacerbada
VRS Positivo
Antecedentes de HTA-EPOC-Hipotiroidismo-DM IR-TACO por TVP, ERC

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E03-OTRO HIPOTIROIDISMO. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I47.2-TAQUICARDIA VENTRICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 76 años, con antecedentes de HTA-EPOC-Hipotiroidismo-DM IR-TACO por TVP, alérgica al DICLOFENACO. Consulta en Urgencia por disnea y ruidos respiratorios audibles al medio desde hoy. A su ingreso hipertensa, taquicardia, taquipnea, afebril, hiperglicémica, sat 90-91% con apoyo de O2 por NRC 2 lts posterior se titula a la baja por sat 96%, al EF GLW 15 pts, piel pálida, tibia al tacto, PIRRL, yugulares planas, tórax simétrico, ventilando con apremio, Abdomen blando, depresible, sensible a la palpación, leve distendido, EESS sin edema, EEII leve edema (+-).
GSA destaca: PH 7.34 pco2 29 PO2 60.1 PAFI 286
Residente UTI Se solicita evaluación, paciente con antecedentes de Hipotiroidismo, HTA, DM2IR, EPOC en tratamiento con salbutamol c/12 hrs, b ipratropio c/12 hrs y trelegy 1 vez al dia. Hace 3 dias con exacerbación de disnea asociado a tos productiva mucupuruenta. A su llegada con requerimiento de apoyo con Fio2. Se administran corticoides ev + nebulizaciones con Berodual. Examenes de laboratorio: Crea 2.3, lactato 1.4, PCR 83, Uremia 86, ELP 136/4.5/105 GB 8300 INR 1.49 DD 868 GSA pH 7.34 pO2 60 pCO2 39 HCO3 21 FiO2 21%. Antigenos virales negativos GSA de control: pH 7.35 pO2 81 pCO2 41 HCO3 23 FiO2 28%. cursando cuadro compatible con EPOC exacerbado, actualmente sin indicacion de apoyo con VMNI, sin criterios de ingreso a UTI en este momento. Se sugiere favorecer tratamiento broncodilatador, corticoides ev, antibioticos para cobertura de la comunidad, tomar CSB, solicitar panel viral HCHM, FiO2 para saturar 88-90%, hidratacion juiciosa y vigilada. Evitar nefrotoxicos. Control de GSA a las 21.00 hrs y observar evolución clínica.
Evoluciona favorablemente con parámetros inflamatorio sin elevación, panel viral positivo para VRS. Sin fiebre, sin apremio respiratorio. En condiciones de continuar tto HODOM.

PLAN DE MANEJO:

KINE respiratoria por Hodom
rescatar urocultivo

continuar con esquema de TACO Habitual
control sos urgencia

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen liviano hiposódico-diabético Restricción hídrica 800 cc dia
2. Ceftriaxona 2 gr ev cada 24 horas competar 10 dias (4/10)
3. Prednisona 40 mg dia por 5 dias vo
4. omeprazol 20mg vo dia por 30 dias
5. Furosemida 40mg cada 12 horas vo
6. Losartan 50mg cada 12 horas vo
7. Carvedilol 6.25mg 1 comp cada 12 horas vo
8. Levotiroxina 50mcg : 1.5 comp cada 24 horas vo
9. Salbutamol 2 puff con Aero cámara cada 6 horas
10. Fluticasona 2 puff cada 12 horas
11. Trelegy 1 puff al dia
12. KINE respiratoria por Hodom
13. Rescatar urocultivo
14. continuar con esquema de TACO Habitual
15. control sos urgencia

EXÁMENES Y RESULTADOS

Creatinina : 2,40 * mg/dl Clearence Calculado(MDRD) : 19,63 Proteina C Reactiva : 44,0 Sodio (Na) : 144,00 mmol/L Potasio (K) : 4,00 mmol/L Cloro (Cl) : 105,00

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO